

ANÁLISE COMERCIAL · JULHO 2026

Auditoria da Apresentação Comercial

Análise comparativa com o framework comercial Full Sales. Avaliação do potencial de conversão da apresentação da Implantação GES360, sem julgamento da qualidade técnica do método ou da entrega.

RESUMO EXECUTIVO PONTOS FORTES DIAGNÓSTICO CENTRAL OPORTUNIDADES

VALOR E PREÇO PROVA SOCIAL COMPARATIVO ESTRUTURA RECOMENDADA PRIORIDADES

CLIENTE

Guilherme Eduardo · GES360

ESTRATEGISTA

Daniel Souza

Material forte em prova. Falta a construção que antecede o preço.

O que foi analisado, o que já funciona e onde está a distância para o framework.

Objetivo. Avaliar a estrutura comercial da apresentação usada na venda da Implantação GES360 (R\$ 15.000), comparando com o framework Full Sales, que a Simple usa como referência de apresentação de alto ticket. Não é uma avaliação da qualidade do método nem da sua entrega: é sobre o potencial de conversão do material dentro da call.

Conclusão. A apresentação tem dois ativos que a maioria dos concorrentes não tem: identidade visual madura e prova social real e abundante, com print de conversa e número. Isso resolve bem a pergunta "isso funciona?".

O problema não está no que existe, e sim na **ordem** e no **que falta antes do preço**. Hoje o material abre explicando o método para um médico que ainda não foi conduzido a reconhecer o tamanho do próprio problema. Depois entrega sete provas seguidas, uma lista de entregáveis e o preço. Em 15 slides não existe: promessa, autoridade do Guilherme, contraste entre cenário atual e desejado, riscos de continuar como está, detalhamento da jornada de 90 dias e nenhuma construção de valor antes do número.

POR QUE ISSO IMPORTA

O médico chega no slide de R\$ 15.000 sem régua de comparação. Quando não existe valor ancorado, o preço é comparado com o que ele imagina, e a conta que ele faz sozinho é sempre a pior possível ("seis reuniões por R\$ 15 mil"). É assim que nasce a objeção de preço que você já escuta hoje, e ela é uma objeção de construção, não de valor real da entrega.

QUALIDADE
VISUAL

Alta

PROVA SOCIAL

**Alta em
volume**

AUTORIDADE

Ausente

CONSTRUÇÃO DE
VALOR

Ausente

ADERÊNCIA AO
FSS

Parcial

Observação importante: quase todo o conteúdo que falta já existe escrito e aprovado no seu canvas e na estratégia do funil. O trabalho aqui é transportar para os slides na ordem certa, não criar do zero.

O que já está funcionando e não deve ser mexido

Quatro ativos que sustentam a base do material.

1. Prova social real, em volume e com print

Sete slides de resultados com números específicos (R\$ 16.000, R\$ 36.400, R\$ 27.152, R\$ 50.800, R\$ 86.771) e prints de conversa real. O case do Dr. Kayo ainda traz uma tabela de evolução mensal com seis meses de dados, o que é raro no mercado.

POR QUE É FORTE

O médico é cético por formação: foi treinado a exigir evidência antes de aceitar conclusão. Print de conversa com número e horário é evidência, não promessa. É também a sua maior vantagem contra os concorrentes de mentoria em massa que você mapeou (Sandro Ferraz, Cassiano Sávio): eles vendem volume e mindset, você mostra resultado individual rastreável.

2. Identidade visual madura e coerente com o ticket

O navy com dourado comunica seriedade e valor alto, e não parece material de infoproduto. A capa com foto e o slide de preço em bloco cheio funcionam bem.

POR QUE É FORTE

Material com aparência barata força o desconto antes de você abrir a boca. O seu já sustenta visualmente o preço de R\$ 15.000: esse trabalho está feito e não precisa ser refeito.

3. Método nomeado e estruturado em pilares

O GES360 aparece com os três pilares (Modelo de Receita, Posicionamento e Atração, Comunicação e Vendas), com um slide dedicado a cada um e objetivo declarado.

POR QUE É FORTE

Sem mecanismo com nome próprio, você vende horas e entra na comparação de preço por hora. Com método nomeado, você vende propriedade intelectual, e propriedade intelectual não tem tabela de comparação no mercado.

4. Os prints de percepção (slide 6) já fazem o trabalho certo

As duas mensagens ("pode contar com alguém que realmente entende a realidade da clínica" e "a análise que você fez trouxe uma clareza absurda") vendem a experiência de trabalhar com você, não só o número.

POR QUE É FORTE

Número prova que funciona. Fala de percepção prova como é conviver com você nos 90 dias, que é exatamente o que o médico está comprando num produto de implementação individual.

A ordem da narrativa é o ponto que explica quase tudo

Um único ajuste estrutural responde pela maior parte da distância para o framework.

SEQUÊNCIA ATUAL

Método (slides 2 a 5) para **Provas** (6 a 13) para **Entregáveis** (14) para **Preço** (15)

SEQUÊNCIA DO FRAMEWORK FULL SALES

Promessa para **Autoridade** para **Problema** para **Consequência** para **Desejo** para **Risco** para Benefício para **Método** para Produto para **Valor** para Prova para **Preço**

Abrir pelo método é responder "como funciona?" antes de o médico ter perguntado "por que eu preciso disso?". Nesse momento da call ele ainda está decidindo se tem um problema grande o bastante para justificar mexer na clínica. Quando você explica pilares para quem ainda não reconheceu o próprio gargalo, o material vira aula. Ele acha interessante, elogia, e não fecha. Interessante não move R\$ 15.000.

O PARALELO COM O QUE VOCÊ MESMO ENSINA

O GES360 diz ao médico para não trazer mais paciente antes de arrumar o modelo de receita: preço e protocolo primeiro, tráfego depois. A sua apresentação comercial hoje comete, na venda, exatamente o erro que o seu método corrige na clínica: entrega a solução antes de estruturar o que faz o cliente querer comprar. Corrigir a ordem do material é aplicar o GES360 na sua própria oferta.

Por que a ordem não é firula. O médico decide por identificação, não por informação. Ele precisa se ver descrito num slide antes de conseguir escutar a sua solução. E o material para fazer isso já está pronto: o bloco de dor do ICP, o reframe das três alavancas e a big idea aprovada na estratégia do funil. Nada disso está hoje na apresentação.

Promessa, autoridade e o contraste de cenários

Os três blocos que faltam no início e que sustentam tudo que vem depois.

1. Não existe promessa nos primeiros slides

A capa traz a logo e o slide seguinte já entra nos pilares do método. O médico passa a apresentação inteira sem uma frase que diga o que ele vai conquistar.

SUGESTÃO DE COPY (JÁ APROVADA NA SUA ESTRATÉGIA)

Headline: Dobre o faturamento da sua clínica sem aumentar o número de atendimentos.

Subheadline: Saindo da dependência da consulta avulsa para um modelo de receita recorrente e previsível.

Três benefícios: receita previsível todo mês · um programa que o paciente fecha sem você precisar empurrar · secretária treinada para não perder oportunidade.

POR QUE IMPORTA

A promessa é o contrato de atenção da reunião. Sem ela, os 14 slides seguintes não têm âncora: o médico assiste sem saber para onde a conversa está indo, e quem não sabe onde a conversa vai não se compromete com o final dela.

2. O Guilherme não aparece em nenhum slide

Em 15 slides não existe um único bloco sobre quem conduz a implementação. O material vende o método e os resultados, mas não a pessoa que vai sentar com o médico nas seis sessões.

POR QUE IMPORTA

O produto é implementação individual assistida: o médico não está comprando um curso, está comprando você. Autoridade aqui não é vaidade, é redução de risco percebido na hora de pagar R\$ 15.000 a alguém que ele conheceu por um anúncio. E é o seu diferencial declarado contra as mentorias em massa: lá ele compra uma turma, com você ele compra acompanhamento individual.

SUGESTÃO DE CONTEÚDO

Um slide "Quem conduz a implementação", com foto e quatro marcos reais: a trajetória dentro do mercado médico como representante de farmácia de manipulação e de implante hormonal, os anos visitando clínicas e consultórios todos os dias, o método construído a partir da dor observada dentro da clínica (e não da teoria), e os resultados já entregues. Depois, um slide de comprovação com fotos de eventos e bastidores.

Atenção: a sua própria página (gesconsultoriamedica.com) já tem esse bloco, no "Quem lidera o programa?". Ele existe na landing e falta justamente na peça em que a decisão acontece.

O contraste entre o cenário atual e o desejado

O slide mais importante do framework e o mais ausente na apresentação de hoje.

3. Não existe contraste entre cenário atual e desejado

É a estratégia que o framework chama de "céu e inferno", e é ela que cria a necessidade de agir agora, em vez de agir algum dia. Hoje a apresentação não tem nenhum slide em que o médico se reconheça antes de você apresentar a solução.

CENÁRIO ATUAL (O INFERNO)

- Agenda cheia e o dinheiro não sobra no fim do mês
- Se parar de atender, o faturamento para junto
- Oferece o programa e ouve "vou pensar"
- "Eu não sou bom em vendas"
- Vê médicos mais novos crescendo mais rápido
- **Implicação:** mais um ano trocando tempo por dinheiro, com o teto sendo a própria saúde

CENÁRIO DESEJADO (O CÉU)

- Faturar R\$ 86 mil atendendo 16 pacientes
- Saber exatamente o que ofertar em cada consulta
- Receita previsível todo mês
- Secretária conduzindo o processo sem você
- Sair dos plantões e ter tempo com a família
- **Implicação:** a clínica passa a crescer sem depender de você atender mais

POR QUE IMPORTA

Nenhuma dessas frases foi inventada: todas saíram do seu canvas e das suas calls, na linguagem do próprio médico. É por isso que funcionam. Quanto mais nítido o contraste, maior a urgência, e urgência é o que faz o preço parecer pequeno diante do custo de continuar igual.

COMO APLICAR NA PRÁTICA

O framework recomenda dividir esse conteúdo em **dois slides consecutivos**, e não em um só: primeiro o cenário atual sozinho, deixando o médico sentir o peso da situação, e só depois o cenário desejado. Quando os dois aparecem juntos na mesma tela, o olho vai direto para a solução e a dor não chega a ser processada.

Na condução da call, esse é o momento de parar de apresentar e perguntar: "doutor, qual desses pontos mais parece a sua clínica hoje?". A resposta dele passa a ser a linha condutora do restante da apresentação, e o método deixa de ser uma explicação genérica para virar resposta ao que ele acabou de admitir em voz alta.

Risco, jornada e a metodologia que está invisível

O que falta no miolo da apresentação, entre o método e a oferta.

4. Falta o slide de risco de tentar sozinho

O médico sempre tem a alternativa gratuita: tentar por conta, copiar de um colega, pedir para a secretária resolver.

SEIS RISCOS SUGERIDOS

Precificar no chute e ancorar o programa abaixo do valor · montar protocolo que o paciente não entende · treinar a secretária sem script e queimar a base · testar no paciente real e perder credibilidade · levar doze meses para chegar onde daria em noventa dias · desistir na primeira objeção de preço e voltar para a consulta avulsa.

POR QUE IMPORTA

Você não concorre apenas com outras mentorias, concorre principalmente com a inércia. Nomear o custo de tentar sozinho é o que transforma "depois eu vejo isso" em "melhor fazer com quem já fez", e é a única forma de disputar contra a alternativa que não custa nada.

5. A jornada de 90 dias está resumida em um bullet

Hoje, noventa dias de trabalho aparecem como uma linha: "6 encontros em 90 dias". O seu canvas, porém, já descreve sessão por sessão o que acontece.

O QUE JÁ EXISTE NO SEU CANVAS E DEVERIA ESTAR EM SLIDES

Sessão 1: diagnóstico da clínica, definição de ICP, comparação do modelo atual com o de acompanhamento e identificação dos gargalos (preço baixo, público errado, pacote mal estruturado, secretária perdendo leads).

Sessão 2: criação dos protocolos, precificação estratégica e a Metodologia de Conversão em Consulta. Primeiros fechamentos na mesma semana.

Sessões 3 e 4: processo comercial, script da secretária, treinamento de recepção e primeiras ações de captação.

Sessões 5 e 6: otimização com dados reais, ajuste de oferta e planejamento da virada para o programa de doze meses.

POR QUE IMPORTA

Valor percebido é proporcional ao trabalho que o cliente consegue enxergar. "Seis encontros" parece seis reuniões, e seis reuniões por R\$ 15.000 dá uma conta ruim na cabeça dele. A mesma entrega, detalhada em fases com objetivo e entregas, parece um sistema de implantação. É o mesmo trabalho com o dobro de valor percebido, e é a correção mais barata desta auditoria: o conteúdo já está escrito.

6. A Metodologia de Conversão em Consulta não aparece

As seis etapas (Abertura, Conexão, Mapeamento, Direcionamento, Apresentação e Fechamento) estão no seu canvas e não estão na apresentação.

POR QUE IMPORTA

É o único ativo do seu método que ataca de frente a dor número um do seu ICP, que na fala dele é "eu não sou bom em vendas". Ele não quer virar vendedor, e tem medo de parecer charlatão. Mostrar um processo de consulta com nome e etapas tira o peso da palavra venda e transforma o assunto em competência clínica, que é algo que médico aceita comprar.

7. Os entregáveis são listados, mas não demonstrados

Sete bullets em um slide. O framework prevê um slide por entregável, com print real do material.

POR QUE IMPORTA

Bullet é promessa, print é prova. Mostre a planilha de precificação preenchida, o documento do diagnóstico financeiro, o material de treinamento da secretária e o PDF da metodologia. O médico compra o que consegue imaginar recebendo, e cada entregável demonstrado permite atribuir preço individual na ancoragem.

8. Não existem bônus

Bônus não é brinde: é ferramenta de quebra de objeção específica.

SUGESTÕES ALINHADAS ÀS OBJEÇÕES REAIS

Modelo de contrato e termo do programa de acompanhamento (resolve "e a parte legal?") · banco de scripts de WhatsApp para reativação de base (resolve "por onde eu começo?") · checklist de implantação da secretária (resolve "minha equipe não vai dar conta").

Do entregável direto para o preço, sem nenhuma ponte

O intervalo entre o slide 14 e o slide 15 é onde a venda de alto ticket é ganha ou perdida.

Hoje a apresentação salta da lista de entregáveis (slide 14) para R\$ 15.000 (slide 15). Entre os dois não existe nada: nem educação de valor, nem ancoragem, nem justificativa de condição, nem prova posicionada para sustentar o número.

O que o framework prevê nesse intervalo

- **Dúvidas.** Um slide dedicado a limpar todas as perguntas antes de falar de dinheiro. Negociar com dúvida em aberto é negociar contra você mesmo.
- **Valor versus preço.** Estabelecer que preço é o que se paga e valor é o que se recebe. Isso prepara a régua de comparação antes do número aparecer.
- **Ancoragem.** Listar cada entregável com valor individual, somar o total e só então revelar o investimento real.
- **Prova posicionada.** Parte dos cases deve estar aqui, sustentando o preço, e não toda concentrada no meio da apresentação.
- **Valor de tabela** com comparativo entre o que ele recebe e o que paga.
- **Justificativa da condição especial** para quem decide na call, com um motivo plausível.

POR QUE ESTE É O PONTO MAIS CRÍTICO DE TODA A AUDITORIA

Sem ancoragem, R\$ 15.000 não é comparado com o valor entregue: é comparado com o que o médico imagina. E a conta que ele faz sozinho é sempre a pior possível, do tipo "seis reuniões, dois mil e quinhentos por reunião". Com a jornada detalhada e a ancoragem feita, a conta que ele faz passa a ser outra: um sistema de receita, implantado dentro da clínica dele, por menos do que várias das clínicas dos seus cases ganharam a mais já no primeiro mês.

A melhor ancoragem já está nos seus próprios cases, e está implícita

Vários dos resultados que você mostra têm um detalhe que nunca é dito em voz alta: **o ganho adicional do primeiro mês supera o investimento total no programa.** Uma clínica que sobe R\$ 48 mil no primeiro mês, ou que fecha R\$ 36.400 em dois dias de atendimento, pagou o programa antes de terminar a primeira fase.

POR QUE PRECISA ESTAR ESCRITO

Hoje isso está subentendido e depende do médico fazer a conta sozinho, no meio de uma reunião, enquanto processa outras informações. Ele não vai fazer. Um slide que apresente essa relação de forma explícita transforma o preço de custo em retorno, que é a única forma de um número deixar de ser objeção.

Muito volume, pouca variedade e no lugar errado

Sete slides consecutivos que quebram todos a mesma objeção.

Os slides 7 a 13 repetem a mesma estrutura: título idêntico, números de faturamento e print. É bastante material, mas concentrado em um único tipo de argumento.

Os três problemas

- **Fadiga de repetição.** O mesmo título sete vezes seguidas faz o cérebro parar de ler a partir do terceiro. A prova de número seis é tão boa quanto a primeira e será ignorada.
- **Todos quebram a mesma objeção.** Todos respondem "isso funciona?". Nenhum responde "funciona no meu caso?", "dá muito trabalho?", "minha secretária consegue?" ou "funciona na minha especialidade?".
- **Cases anônimos.** Com exceção do Dr. Kayo, os resultados aparecem como "a clínica". Case sem nome vale menos, porque o médico não consegue verificar nem se projetar.

Sugestões

- Reduzir para três ou quatro casos no corpo da apresentação e reposicionar dois ou três para depois do preço, sustentando a oferta.
- Trocar o título repetido por um título que nomeie a objeção que aquele case quebra: "Funciona em 30 dias", "Funciona sem atender mais dias", "Funciona com a secretária que ele já tem", "Funciona na sua especialidade".
- Nomear os cases com autorização. O Dr. Kayo já tem autorização em contrato, com print e vídeo liberados (registrado no seu canvas): use nome, especialidade e foto.
- Converter prints em depoimentos de vídeo usando o Guia de Captação de Depoimentos que a Simple já entregou. Médico falando em vídeo vale mais do que qualquer print, porque o espectador é médico também.

POR QUE REPOSICIONAR PARTE DA PROVA

Prova social tem duas funções distintas: antes da oferta ela cria credibilidade, depois do preço ela reduz o medo de errar na decisão. Concentrar tudo no meio gasta munição no momento em que o médico ainda nem sabe quanto custa, e deixa o momento da decisão sem nenhum apoio.

Ajustes rápidos, de alto impacto e baixo esforço

Itens que podem ser corrigidos hoje, antes da próxima call.

1. Erro de grafia recorrente: "METÓDO"

A palavra aparece grafada como **METÓDO** em pelo menos oito slides (no slide de pilares e em todos os sete slides de prova). A forma correta é **MÉTODO**.

POR QUE É SÉRIO E NÃO É DETALHE

Você vende rigor de processo e organização a um público de formação acadêmica, treinado a revisar texto. Um erro ortográfico repetido oito vezes no material principal sugere descuido, e o médico projeta esse descuido na entrega que ele ainda não conhece. É o item de melhor relação entre esforço e risco evitado de toda esta auditoria.

2. Duplicação no slide de pilares

No slide 2 consta "**COMCOMUNICAÇÃO E VENDAS**". O correto é "**COMUNICAÇÃO E VENDAS**".

3. Tabela cortada no case do Dr. Kayo

No slide 12, o título da tabela aparece cortado pela borda superior do card, exibindo "**VOLUÇÃO MENSAL**" no lugar de "**EVOLUÇÃO MENSAL**".

POR QUE CORRIGIR

É justamente o slide do seu case mais forte, o único com série histórica. Um defeito visual nesse slide enfraquece exatamente a peça que deveria ser a mais sólida.

4. A leitura dos números do case principal pode ser questionada

A narrativa parte de abril (R\$ 20.546) para maio (R\$ 86.771), citando crescimento acima de 300%. A tabela ao lado, porém, mostra janeiro em R\$ 26.297, fevereiro em R\$ 19.769 e março em R\$ 43.750. Ou seja: abril foi o segundo pior mês da série.

ENQUADRAMENTO SUGERIDO, MAIS DEFENSÁVEL E IGUALMENTE FORTE

Média dos quatro primeiros meses: **R\$ 27,6 mil**. Média de maio e junho, após a implantação: **R\$ 79,3 mil**. Crescimento de **187% no patamar**, sustentado por dois meses consecutivos.

POR QUE TROCAR UM NÚMERO MAIOR POR UM MENOR

Comparar o melhor mês com o pior mês é a primeira coisa que um médico analítico percebe quando olha a tabela que está no próprio slide, e no instante em que ele percebe, você perde credibilidade nos outros seis cases também. Comparar patamar com patamar dá um número menor, mas blindado, e demonstra o rigor que você quer vender. Prova que resiste a exame vale mais do que prova impressionante.

5. Padronização

Uniformizar a grafia dos valores e sempre indicar o período de apuração ao lado de cada resultado, para que cada número seja auditável.

Framework Full Sales versus apresentação atual

Visão lado a lado dos blocos esperados e o status de cada um hoje.

BLOCO ESTRATÉGICO	FRAMEWORK	APRESENTAÇÃO ATUAL
Capa e identidade	Presente	Forte
Promessa principal e benefícios	Forte	Ausente
Autoridade do expert	Forte	Ausente
Comprovação e bastidores	Presente	Ausente
Trajetória da empresa	Presente	Ausente
Cenário atual versus desejado	Forte	Ausente
Riscos de fazer sozinho	Forte	Ausente
Benefícios e construção de desejo	Forte	Ausente
Método com pilares	Forte	Forte
Detalhamento por pilar	Forte	Forte
Jornada e fases do processo	Forte	Superficial
No que consiste o produto	Forte	Parcial
Entregáveis demonstrados	Forte	Apenas listados
Bônus	Presente	Ausente
Momento de dúvidas	Presente	Ausente
Valor versus preço	Forte	Ausente
Ancoragem de valor	Forte	Ausente
Provas sociais	Forte	Volume alto, variedade baixa
Oferta e valor de tabela	Estruturada	Parcial
Justificativa de condição especial	Presente	Ausente
Condução para a decisão na call	Forte	Ausente

LEITURA DO COMPARATIVO

Os blocos de método e de prova já estão no nível esperado pelo framework e não precisam de retrabalho: são a base sólida do material. As lacunas se concentram em dois lugares muito específicos, e ambos são decisivos. O **início** (promessa, autoridade e construção de problema), que é o que faz o médico querer ouvir. E o **fechamento** (valor, ancoragem, condição e condução), que é o que faz o preço fazer sentido. Hoje a apresentação é forte exatamente no meio e vazia justamente nas duas pontas que decidem a venda.

Roteiro sugerido, aproveitando tudo que já existe

Em azul, o que precisa ser criado. Em cinza, o que já está pronto e apenas muda de posição.

- | | |
|---|--|
| 01. Capa (existe) | 16 a 18. Detalhe de cada fase |
| 02. Promessa e três benefícios | 19 a 21. Provas 1 a 3 (renomeadas por objeção) |
| 03. Quem conduz a implementação | 22. No que consiste a Implantação (slide 14) |
| 04. Comprovação e bastidores | 23 a 25. Entregáveis com print real |
| 05. Cenário atual: o custo de continuar | 26. Bônus |
| 06. Cenário desejado | 27. Dúvidas |
| 07. Riscos de tentar sozinho | 28. Valor versus preço |
| 08. Quanto valeria isso para a sua clínica | 29. Ancoragem: soma dos entregáveis |
| 09. Transição: existe um método | 30 a 31. Provas 4 a 6 posicionadas |
| 10. Pilares do GES360 (slide 2 atual) | 32. Oferta e valor de tabela (slide 15) |
| 11 a 13. Um slide por pilar (slides 3 a 5) | 33. Justificativa da condição especial |
| 14. Metodologia de Conversão em Consulta | 34. Condição para decisão na call |
| 15. A jornada de 90 dias em três fases | |

Não é necessário chegar a essa estrutura completa de uma vez. A página seguinte organiza o que fazer primeiro, por impacto sobre a taxa de conversão.

UMA OBSERVAÇÃO SOBRE EXTENSÃO

Passar de 15 para cerca de 30 slides não deixa a call mais longa: deixa o tempo melhor distribuído. Hoje sete dos seus quinze slides fazem a mesma coisa (provar que funciona), enquanto blocos decisivos não existem. A apresentação reestruturada usa o mesmo tempo de reunião conduzindo o médico por uma sequência de decisão, em vez de repetir sete vezes o mesmo argumento.

O que ajustar primeiro

Ordenado por impacto esperado sobre a conversão, não por facilidade.

PRIORIDADE ALTA · ANTES DA PRÓXIMA CALL

- Corrigir "METÓDO" para "MÉTODO" em todos os slides e a duplicação em "COMCOMUNICAÇÃO"
- Inserir promessa e três benefícios logo após a capa
- Inserir o contraste entre cenário atual e cenário desejado
- Inserir a ancoragem de valor antes do slide de preço
- Inserir um slide de autoridade sobre quem conduz a implementação

São os cinco itens que atuam diretamente sobre a objeção de preço, que é a que você mais escuta hoje. Os quatro últimos usam conteúdo que já existe no seu canvas e na estratégia.

PRIORIDADE MÉDIA · PRÓXIMAS DUAS SEMANAS

- Detalhar a jornada de 90 dias em três fases, com objetivo e entregas por fase
- Incluir a Metodologia de Conversão em Consulta com as seis etapas
- Reduzir os slides de prova e renomear cada um pela objeção que ele quebra
- Criar o slide de riscos de tentar sozinho
- Incluir o slide de dúvidas antes de entrar em preço
- Corrigir a tabela cortada e ajustar a leitura dos números do case principal

PRIORIDADE BAIXA · EVOLUÇÃO CONTÍNUA

- Um slide por entregável com print real do material
- Estruturar bônus por objeção
- Substituir prints por depoimentos em vídeo, usando o guia já entregue
- Criar a justificativa de condição especial e a condição de decisão na call
- Nomear os cases com autorização formal dos médicos

Preservar o visual e a prova. Reconstruir a sequência.

O que muda, o que fica e o resultado esperado.

A apresentação da Implantação GES360 não tem problema de design nem de credibilidade. Tem problema de **sequência** e de **construção de valor**. O material atual responde muito bem à pergunta "isso funciona?" e não responde às duas perguntas que efetivamente destravam um contrato de R\$ 15.000: **"por que eu preciso disso agora?"** e **"por que isso vale esse valor?"**.

Vale registrar o que não deve ser tocado: a identidade visual, a estrutura de pilares do método e o acervo de prova social são ativos maduros e acima da média do mercado em que você compete. O trabalho aqui é de narrativa, não de design.

A BOA NOTÍCIA SOBRE O ESFORÇO ENVOLVIDO

Praticamente todo o conteúdo que falta já existe, escrito e aprovado por você: a promessa e a big idea estão na estratégia do funil, o bloco de dor e o cenário desejado estão no canvas do cliente ideal, a jornada das seis sessões e a Metodologia de Conversão em Consulta estão no canvas do produto, e a autoridade já está redigida na sua própria página de vendas. Não é criação, é transporte para o lugar certo, na ordem certa.

RECOMENDAÇÃO FINAL

Manter a identidade visual, a estrutura de pilares e o acervo de prova. Adicionar promessa, autoridade, contraste de cenários, jornada detalhada e ancoragem de valor. Reposicionar parte da prova social para depois do preço.

Com os itens de prioridade alta, a apresentação deixa de ser uma boa aula sobre um método e passa a ser uma conversa que conduz à decisão, sem trocar uma cor sequer.